



内分泌与代谢 千亿赛道的机会与竞速

2025.08



免责声明

- 幻灯相关内容仅代表个人观点，不代表其他任何人、任何组织立场。在任何情况下，与公司立场无关。
- 本报告所发布的信息以及所表达的意见仅为提供信息参考之目的，不构成决策建议理由和依据。
- 报告中所包含的信息是我们于发布之时从我们认为可靠的渠道获得，但我们对本报告所发布的信息、观点以及数据的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明确或隐含的保证。
- 报告所发布的信息、观点以及数据有可能发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效，在相关信息进行变更或更新时不会另行通知或更新报告。

目录

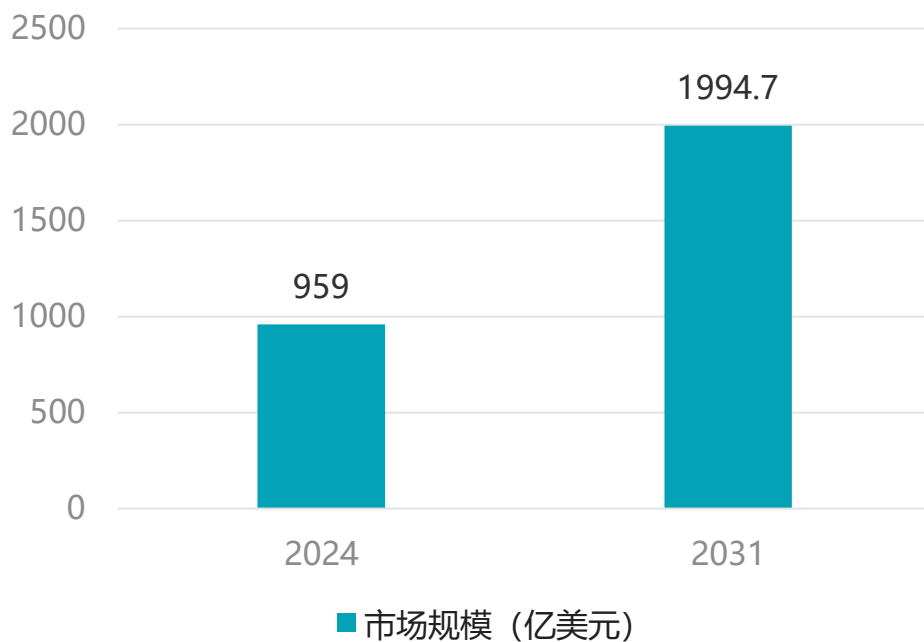
- 01 内分泌与代谢领域的整体概括
- 02 糖尿病、肥胖以及 GLP1R 领域的竞争
- 03 MASH 药物的发展与挑战

全球内分泌与代谢市场规模预计 2031 年达到近 2000 亿美元，将诞生更多百亿级超重磅炸弹

- 2024 年全球内分泌与代谢市场销售额达到了 959 亿美元，预计 2031 年将达到 1994.7 亿美元，年复合增长率（CAGR）为 11.2%（2025-2031）。
- 2025 年上半年，销售额排名前13的药品中，有 4 款内分泌与代谢领域药物。GLP-1成为新药王。

全球内分泌与代谢领域市场规模

预计 2025 - 2031 年 CAGR: +11.2%



2025 年 H1 药品销售额排名

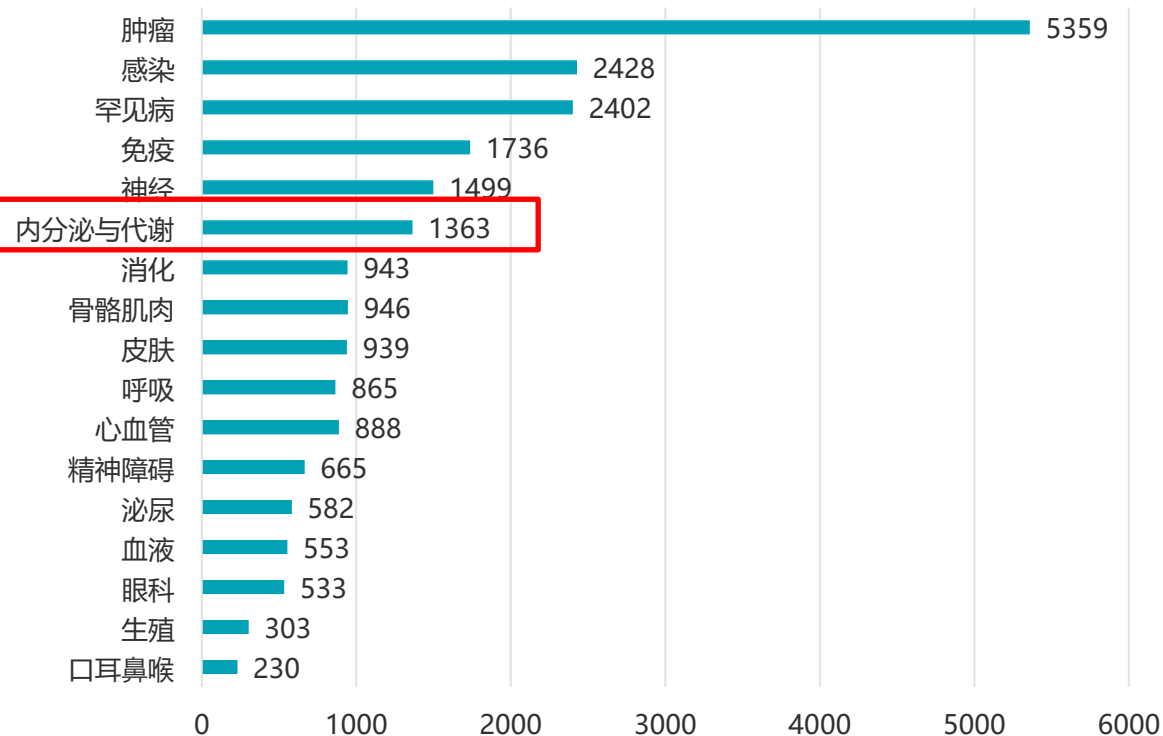
序号	成分	上市时间	企业名称	销售金额 (亿美元)	疾病领域
1	司美格鲁肽*	2017	诺和诺德	165.01	内分泌与代谢
2	帕博利珠单抗	2014	默沙东	151.61	肿瘤
3	替尔泊肽*	2022	礼来	147.34	内分泌与代谢
4	度普利尤单抗	2017	赛诺菲	80.1	免疫
5	利生奇珠单抗	2019	艾伯维	78.48	免疫
6	阿哌沙班	2011	BMS	72.45	心血管
7	达雷妥尤单抗	2015	强生	67.76	肿瘤
8	比克恩丙诺	2018	吉利德	66.79	感染
9	艾伐卡托+替扎卡托+Elexacaftor	2019	Vertex	50.87	罕见病
10	纳武利尤单抗	2014	BMS	48.62	肿瘤
11	恩格列净*	2014	BI	47.03	内分泌与代谢
12	沙库巴曲+缬沙坦	2015	诺华	46.18	心血管
13	达格列净	2012	阿斯利康	42.09	内分泌与代谢

* 多个商品名合并计算

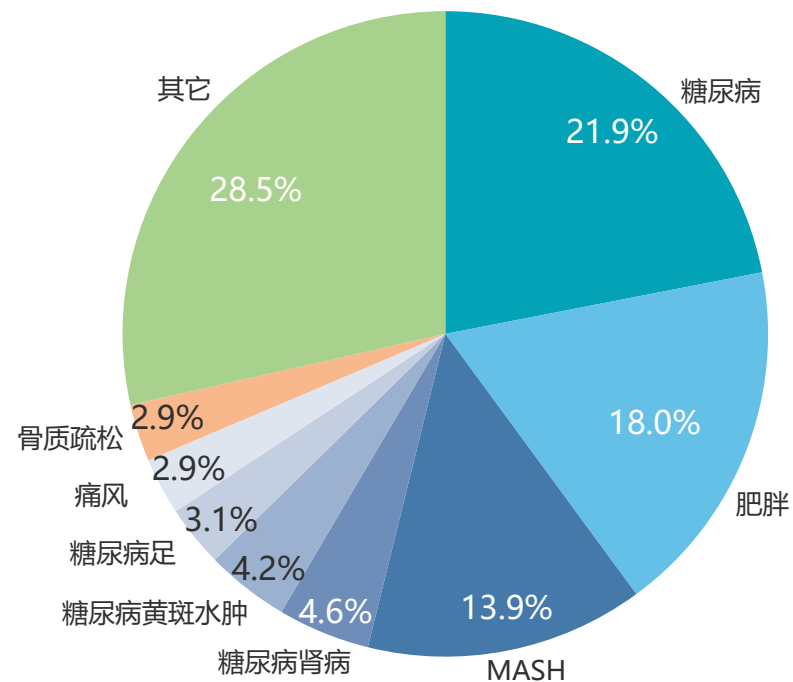
糖尿病、肥胖、MASH 是内分泌与代谢领域全球新药在研管线热度最高的三个疾病

全球已进入临床阶段的在研新药管线中，内分泌与代谢领域共有 1363 条管线，位居第六位。

全球新药管线疾病领域分布情况



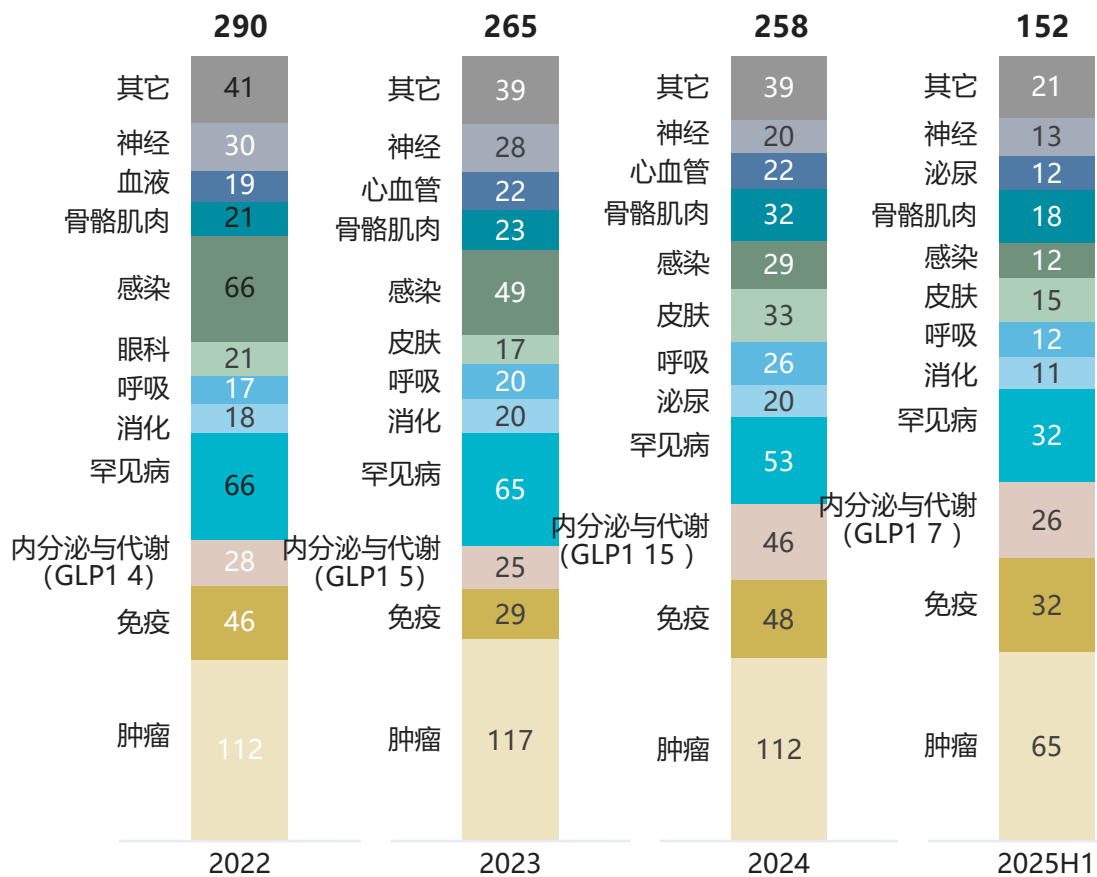
内分泌与代谢领域管线疾病分布情况



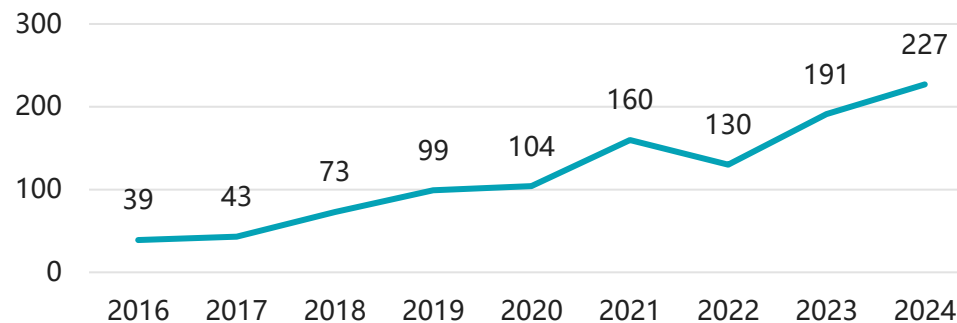
内分泌与代谢领域在国内关注度上升

- 国内 GLP1R 药物交易数量增长推动内分泌与代谢领域的交易事件增长。25年至今，先为达、联邦制药、豪森、石药完成了大额License-Out交易。
- 2024 年，在 CDE 临床试验登记平台登记的内分泌与代谢领域临床试验数量创新高，达 227 条。

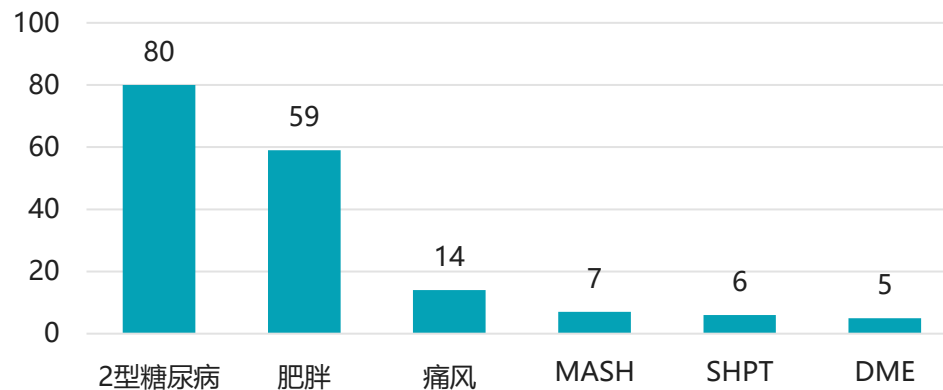
2022-2025 年国内医药交易疾病领域分布情况



历年内分泌与代谢领域临床注册号数量



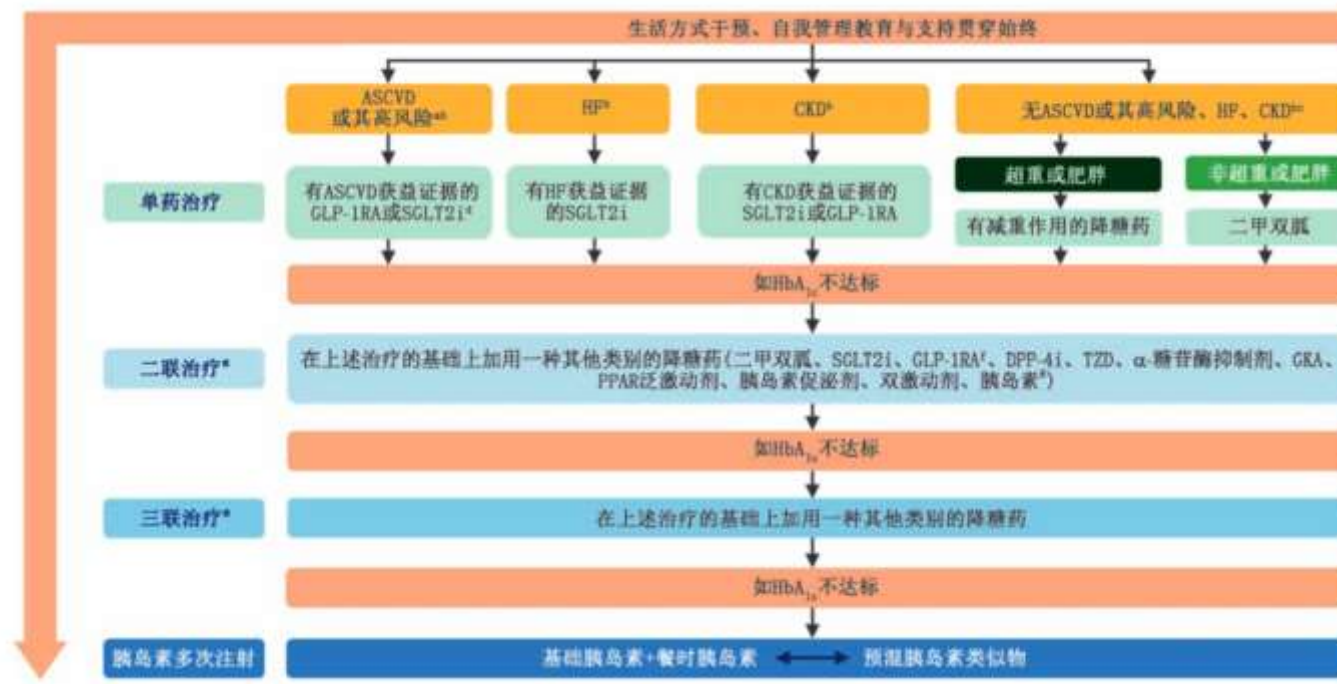
2024 年登记试验数量适应症 TOP5



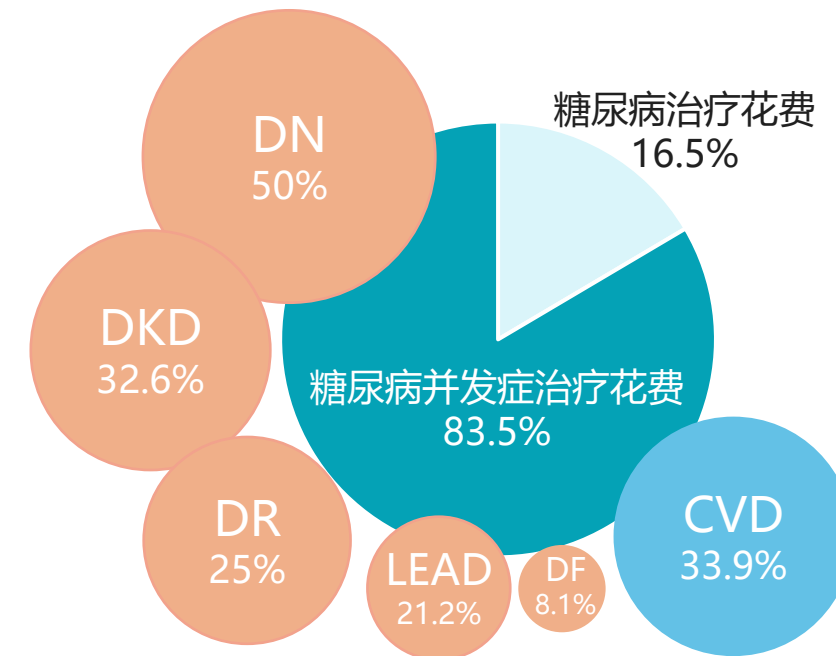
中国糖尿病患者的知晓率、治疗率、控制率均有待提升

- 第 11 版 IDF 《全球糖尿病地图》显示，2024 年中国 2 型糖尿病患者达 1.48 亿，2018 年中国糖尿病患者知晓率、治疗率、控制率约为 43.3%、49%、49.4%，十九大“健康中国行动”提出目标：到 2030 年知晓率、规范管理率分别达到 60%、70%。
- 升阶治疗模式执行困难，多种因素导致糖尿病控制率低，并发症耗费大量医疗资源。

糖尿病治疗路径

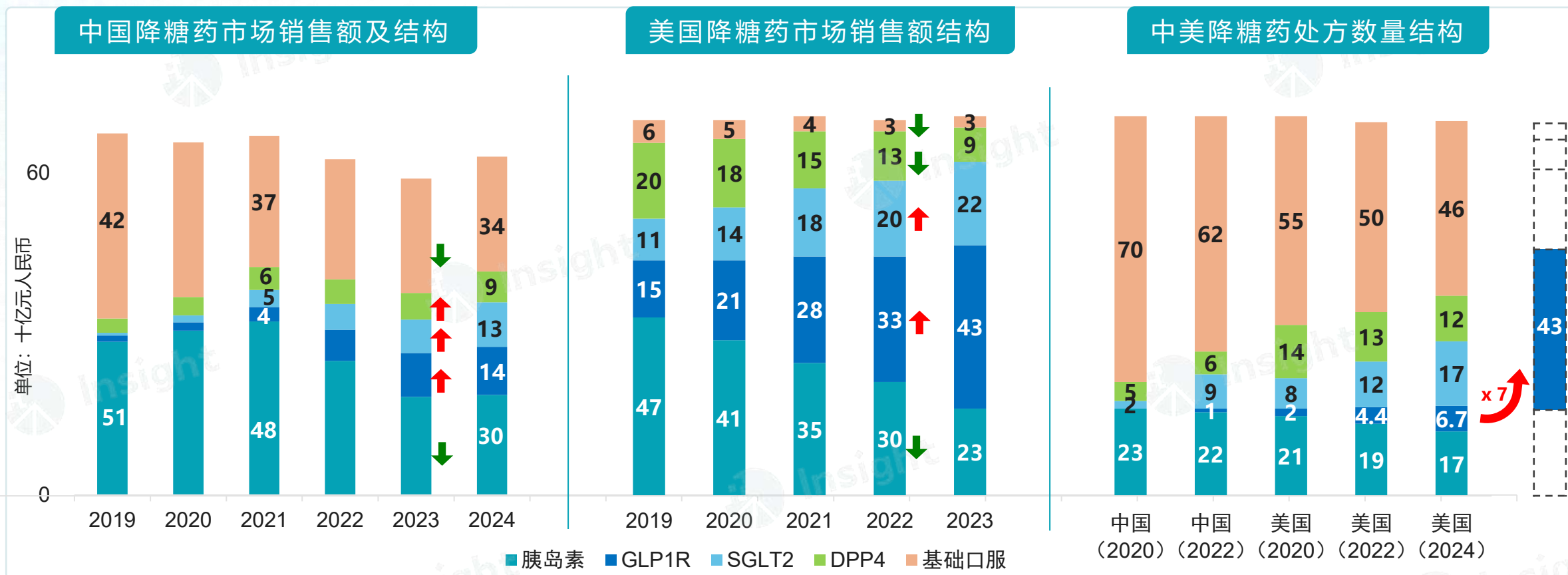


常见糖尿病并发症及发病率



中国降糖药物市场受集采影响后略有下滑，因 GLP1R 增长开始回升，市场结构与国外有差异

- 中国每年糖尿病药物市场销售额超 600 亿元人民币，集采后传统口服降糖药与胰岛素份额逐渐降低。中国基础口服产品（二甲双胍、磺酰脲类、噻唑烷二酮类、α-葡萄糖苷酶抑制剂）的市场占比高于美国水平，GLP1R 市占更低，DPP-4i 市占还未呈现下降趋势，23年以来有5个国产DPP4新药上市。
- 中美市场 GLP1R 产品处方量占比低但销售额占比极高，且增长迅猛。



轻症选口服联用，重症选胰岛素，有特定合并症的选 GLP1R 多肽

- 美国创新药溢价更高
- 对于中国患者，比起口服联用方案或胰岛素方案，GLP1R 方案性价比不高，优势在于对肥胖、CVD、HF、CKD、MASH等合并症方面的额外获益

中美两国糖尿病药物年治疗花费

类别	药物	给药周期	中国年费用 (元)	美国年费用 (美元)
多肽	替尔泊肽*	每周1次	33096	13000
	艾塞那肽微球*	每周1次	23820	
	口服司美格鲁肽*	每日1次	21600	
	依苏帕格鲁肽α*	每周1次	12912	
	洛塞那肽	每周1次	6672	
	利司那肽	每日1次	6432	
	利拉鲁肽	每日1次	6168~7560	11000~13000
	度拉糖肽	每周1次	5921	12000
	司美格鲁肽	每周1次	5056	12000
	艾塞那肽	每日2次	4896	
	贝那鲁肽	每日3次	4584	

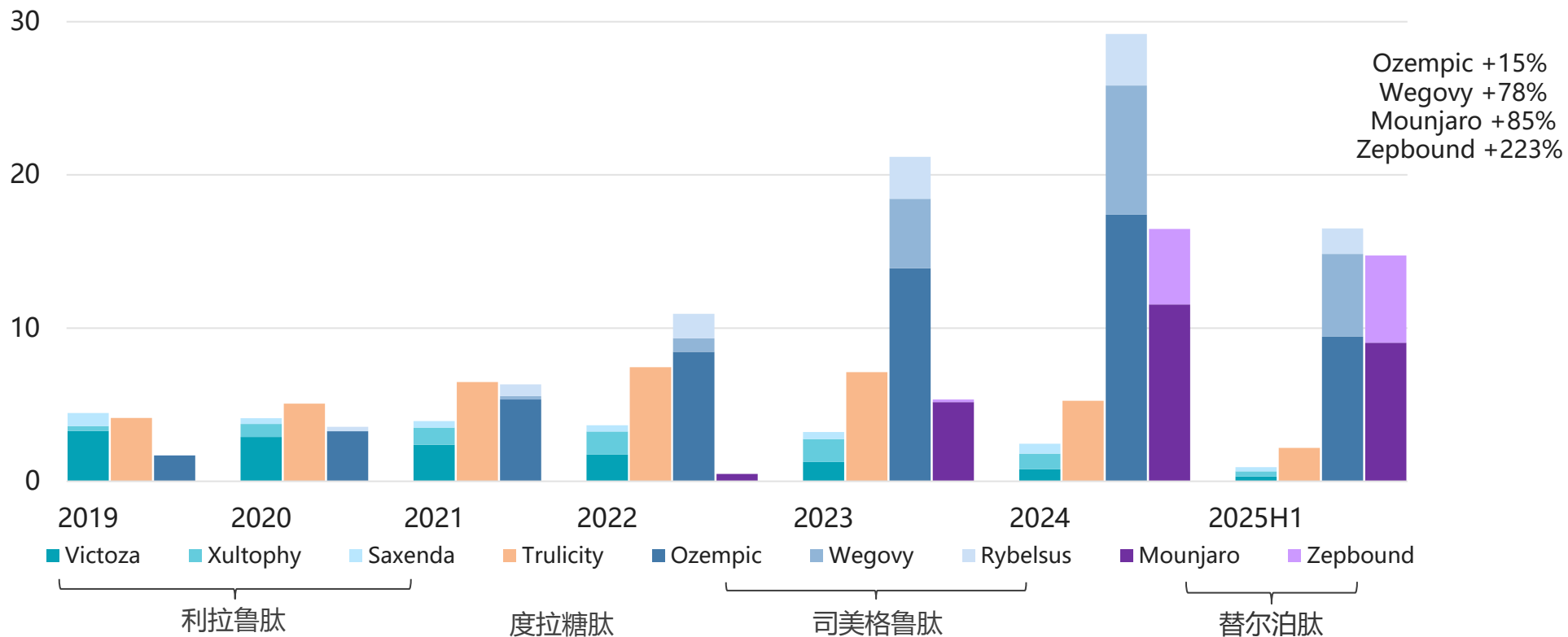
类别	药物	给药周期	中国年费用 (元)	美国年费用 (美元)
复方	德谷胰岛素利拉鲁肽	每日1次	8617	
	甘精胰岛素利司那肽	每日1次	5438	
胰岛素	依柯胰岛素	每周1次	2678	
	三代基础胰岛素	每日1次	1200~1920	
	二代基础胰岛素	每日1次	480~720	
	三代餐时胰岛素	每日3次	480~960	500~6000
	二代餐时胰岛素	每日3次	480~720	
	预混胰岛素	每日1~2次	480~1200	
	SGLT2、DPP4进口原研	每日1次	1440~3240	6000~8000
小分子	SGLT2、DPP4仿制药	每日1次	40~400	
	SGLT2、DPP4国产原研	每日1次	860~7200	
	考格列汀（海思科）	每两周1次	820	
	基础OAD	每日1~3次	100~2000	60~1000

- * 表示未纳入中国医保
- 以临床主流维持剂量计算，浮动范围因不同品牌导致
- 美国价格为当前价格，不包括26年执行的谈判价
- 中美两国价格均未扣除保险报销

全球 GLP1R 市场增长大势所趋，2030 年市场规模或超千亿

- 2024 年礼来与诺和诺德的 GLP1R 药物全球销售额达 534 亿美元，2025 年上半年达到 343 亿美元。
- 减重市场潜力仍未完全释放，多家机构预测 2030 年 GLP1R 药物市场规模将超千亿。

全球已上市 GLP-1R 药物的销售额



国家喊你减肥，2030 年中国减重市场将达 240 亿元人民币

- 中国减重市场仍处于萌芽期，24 年利鲁平+谊生泰/非塑美年销售额约 1 亿人民币。24 年诺和诺德大中华区 Wegovy 销售额 2 亿人民币，25 年 H1 Wegovy 大中华区销售额 8.9 亿人民币。
- 25 年 4 月卫健委发文鼓励有条件的三甲医院设置体重管理门诊，并要求委属、中医药局属、省属综合医院、儿童医院、中医医院在 25 年 6 月底前实现全覆盖。

2030 年中国超重/肥胖成人数量

BMI (kg/m ²)	男性	女性	合计
25~30	236560	153610	390170
30~35	52710	42240	124870
35+	16220	13700	

	中国 (kg/m ²)	国外 (kg/m ²)
肥胖/超重的标准	overweight: 24~28 obesity: ≥28	overweight: 25~30 obesity: ≥30
GLP1R获批人群	≥28、≥24+合并症	≥30、≥27+合并症
司美格鲁肽国内获批 “≥30、≥27+合并症” 人群，“≥28、≥24+合并症” 人群3期研究中		

2030 年中国 GLP1R 药物减肥领域市场空间预测

肥胖人数 150,000,000

Wegovy半年治疗费用:
10000 元



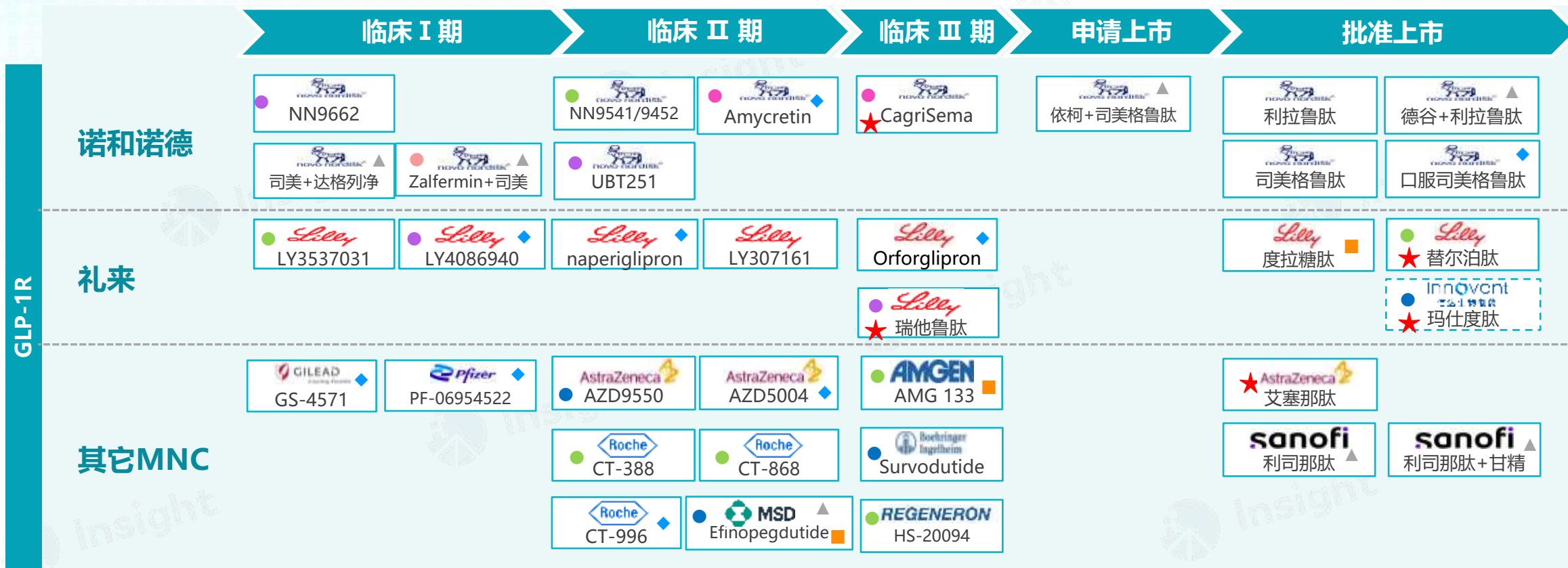
药物干预比例: 2%

专利到期后降价 20%

24年美国肥胖患者使用 GLP1R 的情况:

- 肥胖患者中治疗率 5~10%
- 平均年龄 47 岁，女性占 70%，白人占 70%
- 所有 GLP1R 处方：39% 用于慢性病，38% 用于减重，23% 两者皆有
- 仅 40% 患者使用 Wegovy 持续超过一年，停药原因：副作用（43.7%）、花费（30.9%），不需要（15.3%），依从性（15.3%）、医生要求（13.1%）

MNC 中，诺和诺德与礼来开展军备竞赛，口服制剂是必争之地

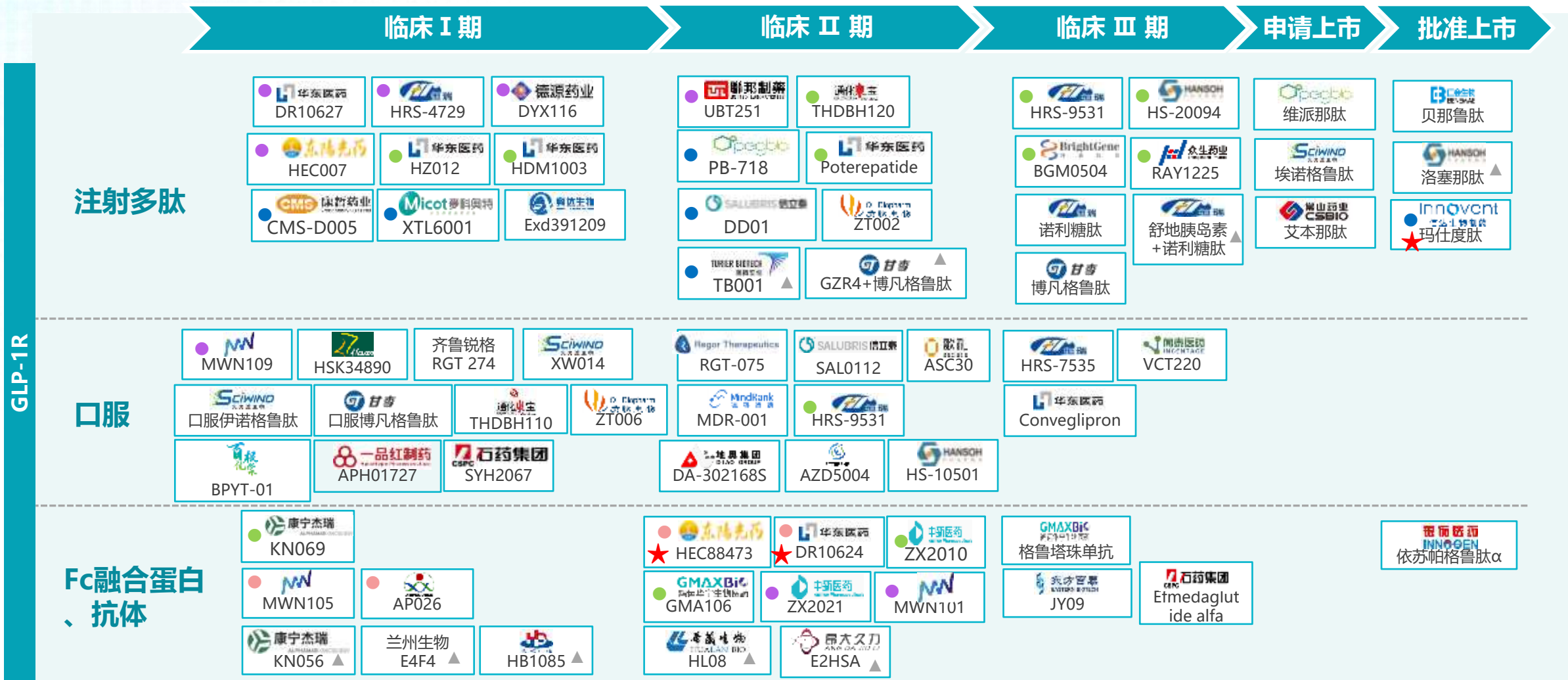


部分失败管线及原因：

Danuglipron (肝损伤)、◆ Lotiglipron (肝损伤)、NN9277 (心率增加)、AZD0186 (药效差)、● MK-8521 (药效差)、MEDI4166 (药效差)、● NN9650 (整体数据一般)、NN9423 (每日注射)、● MEDI0382 (每日注射)、● SAR425899 (每日注射)、● SAR441255 (每日注射)、● LY3493269 (未公开)、MEDI 7219 (未公开)、◆ NN9904 (未公开)

● GIPR + GLP1R ● GCGR + GLP1R ● GCGR + GIPR + GLP1R ● AMYR + GLP1R ● FGF21 双靶/多靶 ◆ 口服 ■ 融合蛋白、偶联药物 ★ 靶点 pFIC/FIC ▲ 没有减重适应症

国内企业 GLP1R 领域内卷严重，在多靶、口服、融合蛋白几种技术上均竞争激烈



● GIPR + GLP1R ● GCGR + GLP1R ● GCGR + GIPR + GLP1R ● FGF21 双靶/多靶 ★ 靶点 pFIC/FIC ▲ 没有减重适应症

类似药过度内卷，2028 年中国将有 20 款司美格鲁肽产品

企业	当前进度与时间	最新进展	预计上市时间
九源基因	申请上市 2024-04-03	2025-06-27 第一轮发补审评中	25 年 H2
丽珠新北江	申请上市 2024-06-13	2025-07-29 第一轮发补审评中	26 年 H1
齐鲁制药（化药）	申请上市 2024-09-15	2025-07-09 离开新报任务（第一轮发补准备中）	26 年 H1
珠海联邦	申请上市 2025-01-24	2025-08-09 新报任务排队待审评（排队41）	26 年 H2
中美华东	申请上市 2025-04-03	2025-08-09 新报任务排队待审评（排队96）	26 年 H2
石药集团（化药）	申请上市 2025-08-05	2025-08-05 新报任务排队待审评（排队241）	27 年 H1
四环医药	申请上市 2025-08-16	2025-08-16 新报任务排队待审评（排队194）	27 年 H1
宸安生物	临床III期 2023-06-19	2024-06-12 试验完成	27 年 H1
成都倍特	临床III期 2024-03-11	2024-08-10 招募完成	27 年 H1
正大天晴	临床III期 2024-01-12	2024-03-15 首例入组	27 年 H1
复星万邦	临床III期 2024-09-12	2024-03-19 首例入组	27 年 H2
华润双鹤（化药）	临床III期 2024-07-18	2025-03-29 招募完成	27 年 H2
质肽生物	临床III期 2024-03-05	2024-07-29 首例入组	27 年 H2
深圳翰宇（化药）	临床III期 2024-09-02	2024-09-23 首例入组	27 年 H2
诺泰生物（化药）	临床III期 2024-11-28	/	27 年 H2
苏州特瑞（化药）	临床III期 2024-12-23	2025-03-31 首例入组	27 年 H2
普洛药业（化药）	临床III期 2025-02-06	/	28 年 H1
乐普药业	临床III期 2025-03-07	2025-03-17 首例入组	28 年 H1
山东新时代	临床III期 2025-03-21	/	28 年 H1

国产 GLP-1R 创新药在降糖领域不逊色 MNC 产品

企业	产品	临床	人数	基线	剂量/给药	对照药	有效性		安全性			
							HbA1c*	统计时间	SAE	AE 导致停药	低血糖	胃肠道 AE
Novo Nordisk	司美格鲁肽	SUSTAIN 3	813	8.3	1.0mg qw	艾塞那肽	-1.5 vs -0.9	56-week	9.4 vs 5.9	9.4 vs 7.2	8.1 vs 8.2	41.8 vs 33.3
		SUSTAIN CHI●	868	8.1		西格列汀	-1.7 vs -0.9	30-week	6.2 vs 4.1	10.7 vs 2.1	2.1 vs 1.4	44.5 vs 19
	口服司美格鲁肽◆	PIONEER 4	711	8	14mg qd	利拉鲁肽	-1.3 vs -1.1	26-week	11 vs 8	11 vs 9	1 vs 2	
		PIONEER 12●	1441	8.2		西格列汀	-1.6 vs -0.6	26-week	3.3 vs 4.4	11.1 vs 2.2	0.4 vs 0	
	●CagriSema	NCT04982575	162▲	8.4	2.4mg qw	司美格鲁肽	-2.18 vs -1.79	32-week	0 vs 6	0 vs 3	6 vs 0	58 vs 32
Eli Lilly	●替尔泊肽	SURPASS-2	1879	8.28	15mg qw	司美格鲁肽	-2.46 vs -1.86	40-week	5.7 vs 2.8	8.5 vs 4.1	1.7 vs 0.4	44.2 vs 41.9
		SURPASS-AP●	907	8.71		甘精胰岛素	-2.49 vs -0.95	40-week	6.6 vs 9.1	12.2 vs 2.7	4.4 vs 4.1	
	Orforglipron◆	ACHIEVE-1	559	8	36mg qd	安慰剂	-1.5 vs -0.1	40-week		8 vs 1		
Eli Lilly 信达	●瑞他鲁肽	NCT04867785	281▲	8.3	12mg qw	度拉糖肽	-2.16 vs -1.36	32-week	4 vs 2	15 vs 2		35 vs 35
	●玛仕度肽	DREAMS-2●	731	8.22	6mg qw	度拉糖肽	-1.73 vs -1.38	28-week		腹泻34.8% vs 22.4%，恶心34.4% vs 17.1%		
BI	●Survodutide	NCT04153929	413▲	8.1	1.8mg qw	司美格鲁肽	-1.71 vs -1.47	16-week	4	21.20		
Amgen	●AMG 133	NCT05669599	127▲	7.9	420mg q4w★	安慰剂	-2.2 vs +0.1	52-week		11		
博瑞	●bgm0504	CTR20232464●	64▲	8	15mg qw	司美格鲁肽	-2.76 vs -1.71	12-week				
恒瑞	●HRS9531	NCT05966272●	199▲	8.2~8.7	3mg qw	安慰剂	-2.7 vs -0.3	20-week				
翰森	●HS-20094	NCT06118008●	54▲		15mg qw	司美格鲁肽	-0.84 vs -0.59	4-week				
众生	●RAY1225	NCT06254274●	174▲		9mg q2w★	安慰剂	-2.16 vs -0.33	24-week				
银诺	依苏帕格鲁肽α	YN011-301●	297		3mg qw	安慰剂	-2.15 vs -0.47	24-week				
甘李	博凡格鲁肽	CTR20232069●	272▲	8.3~8.6	18mg q2w★	司美格鲁肽	-2.28 vs -1.60	24-week				
先伟达	埃诺格鲁肽	EECOH-2●	623		1.2mg qw	度拉糖肽	-1.91 vs -1.65	32-week				
恒瑞	HRS-7535◆	CTR20241537●	155▲	8.5	60mg qd	安慰剂	-1.8 vs -0.4					

*优先选择 efficacy estimand / trial product estimand 的数值
 ● GIPR + GLP1R
 ● GCGR + GLP1R
 ● GCGR + GIPR + GLP1R
 ● AMYR + GLP1R
 ◆ 口服
 ★ 超长效
 ▲ 2 期研究
 ● 中国研究

GLP-1R 药物不断突破减重记录

企业	产品	临床	人数	剂量/给药	剂量	对照组	有效性		安全性		
							减重*	统计时间	SAE	AE 导致停药	胃肠道 AE
Novo Nordisk	司美格鲁肽	STEP 1	1961	体重105.3, BMI 37.9	2.4mg qw	安慰剂	-16.9 vs -2.4	60-week	9.8 vs 6.4	7 vs 3.1	74.2 vs 47.9
		STEP 7●	300	体重96.4, BMI 33.8		安慰剂	-12.5 vs -2.8	40-week	6.2 vs 6.7	3.6 vs 1.9	64.6 vs 33.3
	口服司美格鲁肽◆	OASIS 1	667	体重105.4, BMI 37.5	50mg qd	安慰剂	-17.4 vs -1.8	64-week	9.9 vs 11.2	6.1 vs 3.0	80 vs 48
	●CagriSema	REDEFINE 1	3417	体重106.9	2.4mg qw	司美格鲁肽	-22.7 vs -16.1	68-week			
	●Amycretin	NCT05369390	125▲		20mg qw	安慰剂	-22.0 vs +2.0	36-week			
Eli Lilly	●替尔泊肽	SURMOUNT-1	2539	体重104.8, BMI 38.0	15mg qw	安慰剂	-22.5 vs -2.4	72-week	5.1 vs 6.8	6.2 vs 2.6	35.1
		SURMOUNT-5				司美格鲁肽	-20.2 vs -13.7	72-week			
		SURMOUNT-CN●	210	体重91.8, BMI 32.3		安慰剂	-19.9 vs -2.4	52-week	11.3 vs 8.7	7.0 vs 1.4	
	Orforglipron◆	ATTAIN-1	3127	体重103.2, BMI 37.0	36mg qd	安慰剂	-12.4 vs -0.9	72-week	3.3 vs 0	14.8 vs 2	
	●瑞他鲁肽	NCT04881760	338▲	体重110.2, BMI 38.4	12mg qw	安慰剂	-24.2 vs -2.1	48-week	3 vs 4	16 vs 0	
Eli Lilly 信达	●玛仕度肽	GLORY-1●		体重87.2, BMI 31.1	6mg qw	安慰剂	-14.84 vs -0.47	48-week	6.3 vs 3.5	0.5 vs 1	
BI	●Survodutide	NCT04667377	387▲	体重105.7, BMI 37.1	4.8mg qw	安慰剂	-18.7 vs -2.3	46-week	5 vs 7	29 vs 4	82 vs 42
Amgen	●AMG 133	NCT05669599	465▲	体重107, BMI 38	420mg q4w/q8w★	安慰剂	-19.9 vs -2.6	52-week			
博瑞	●bgm0504	CTR20233198●	120▲		15mg qw		-18.5	24-week			
恒瑞	●HRS9531	HRS9531-301●	567	体重93	6mg qw	安慰剂	-19.2 vs -1.5	48-week			
众生	●RAY1225	CTR20240363●	172		9mg q2w★	安慰剂	-15.05 vs -3.55	24-week			
甘李	博凡格鲁肽	CTR20231695●	340▲		48mg q2w★	安慰剂	-17.29 vs 0.99	30-week			
质肽生物	ZT002	CTR20242527●	303▲	BMI 34.4	160mg q2w/q4w★	安慰剂	clinically meaningful	24-week	(EASD 2025 发布)		
联邦制药	UBT251	CTR20233938●	36▲		6mg/qw★		-15.1	12-week			

SURMOUNT-CN
24-week: ~14.5
36-week: ~18.5

*优先选择 efficacy estimand / trial product estimand 的数值 ●GIPR + GLP1R ●GCGR + GLP1R ●GCGR + GIPR + GLP1R ●AMYR + GLP1R ◆口服 ★超长效 ▲1~2 期研究 ●中国研究

GLP1R 药物在中国降糖 & 减重领域的发展趋势

患者管理

完善诊疗规范，加大糖尿病筛查和干预管理力度，引导肥胖患者理性、合规用药。普及健康生活方式。

用药依从性

从增强给药便利性，降低胃肠道不良反应的角度持续创新，提高慢性疾病患者的粘性。

拓展新适应症

GLP1R 靶点已经在心血管、肝病、OSA、肾病甚至神经领域展现潜力。国内企业在新领域探索上仍有待加强。

合作共赢

避免陷入过度的内卷化竞争，积极开展商业合作与授权获得，实现互利共赢。

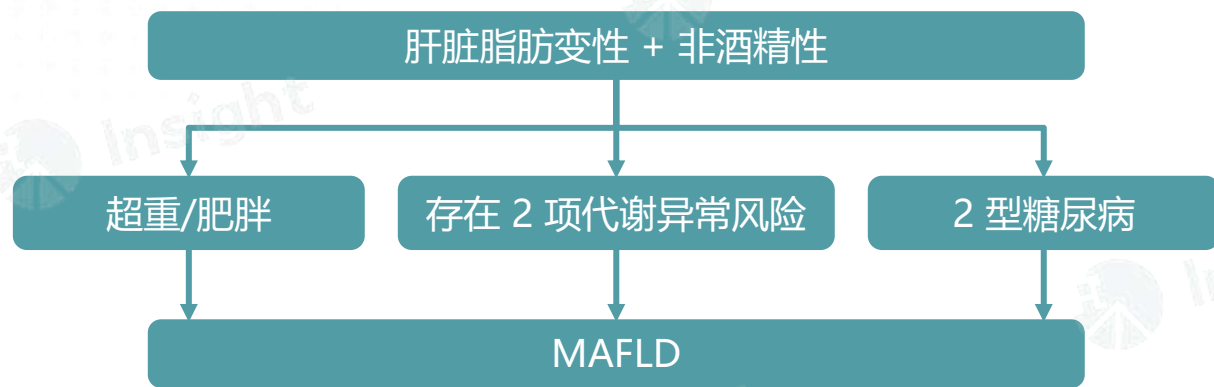
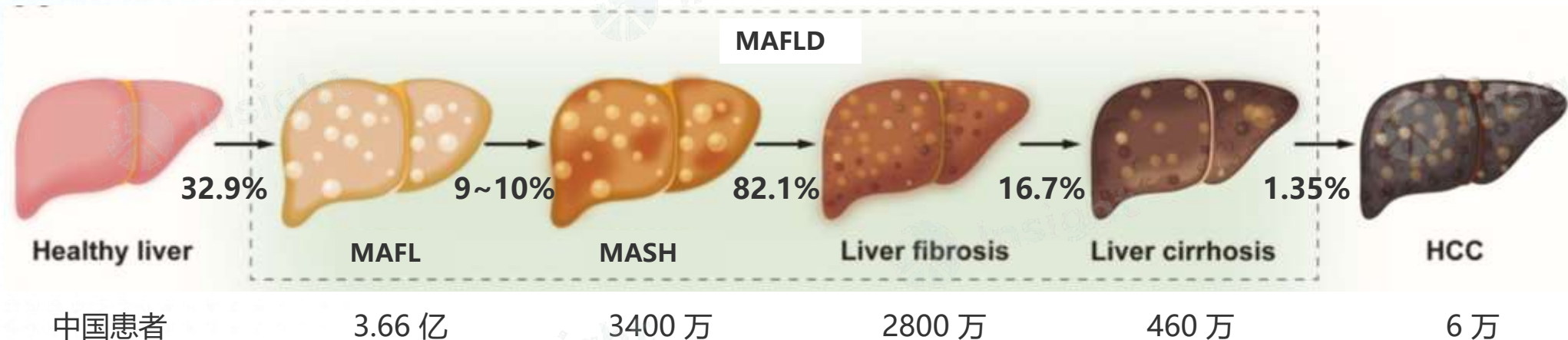
扫码获取全文



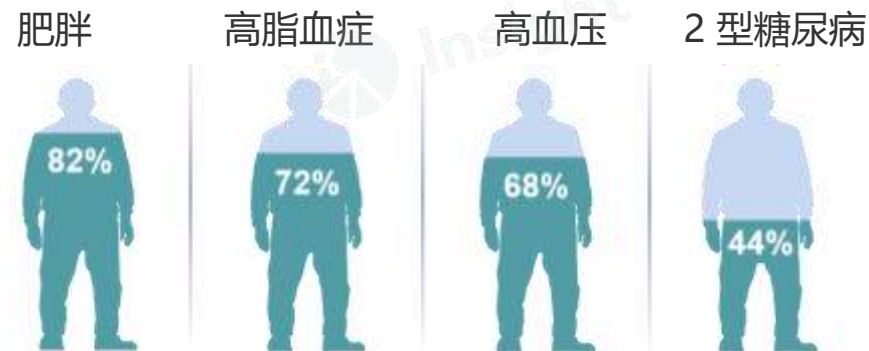
截图保存后微信识别二维码，进入 PDF 下载

中国 3400 万 MASH 患者存在巨大未满足临床需求

- MASH是一种严重的慢性肝脏疾病，中国约有 3400 万患者，可能进一步发展为肝纤维化、肝硬化甚至肝癌。MASH 患者通常伴有其它慢性疾病。
- 2024 年 3 月全球首款代谢功能障碍相关脂肪性肝炎药物获批，中国至今还没有药物申报。



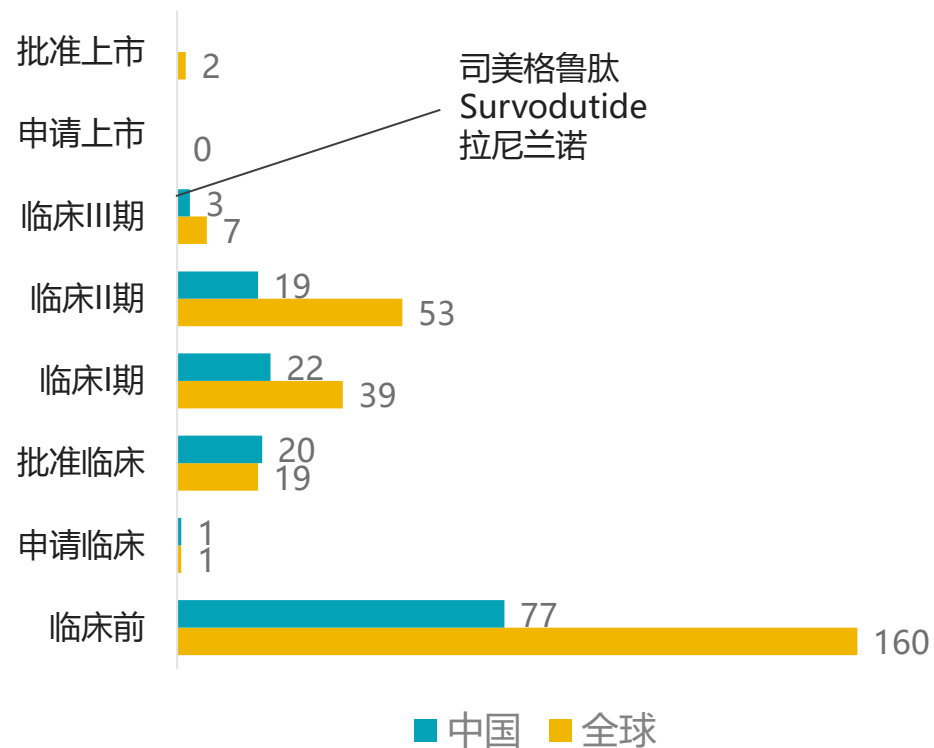
80% 的 MASH 患者有 1 种 以上并发症



MASH 药物研发难度大，成熟管线少

- 在中美欧日主要地区共有 513 个 MASH 产品，其中仍处于积极状态的 281 条管线中 57% 处于临床前阶段，进展到 3 期以上的产品不到 10 个。
- MASH 药物有近一半的失败率，有 52 款产品在进入到临床 2 期后被砍掉。

MASH 在研管线



按MASH适应症的进度统计

MASH 药物失败原因

55%

Active

45%

Inactive

72.6%

3年以上无进展

10.0%

研发策略调整

8.7%

管线移除

7.8%

临床数据不佳

1.0%

监管部门拒绝

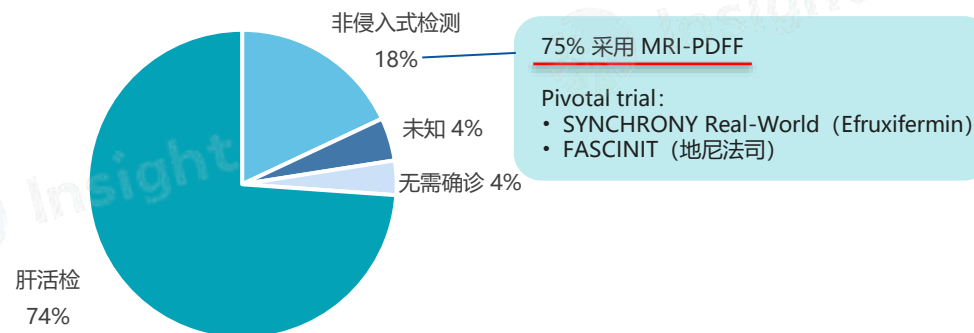
肝脏活检是 MASH 诊断的金标准，需开发更准确地非侵入式检测手段

- MASH 的定义：肝活检组织学提示 $\geq 5\%$ 肝脂肪变性与小叶内炎症和气球样变性并存。现有的无创方法均不能评估小叶内炎症和气球样变性。
- MASH 无创检测方法：血常规与肝功能血清标志物（如血小板、AST）、新型肝损伤血清标志物（如CK-18、PRO-C3）、多参数模型评分、超声、磁共振。

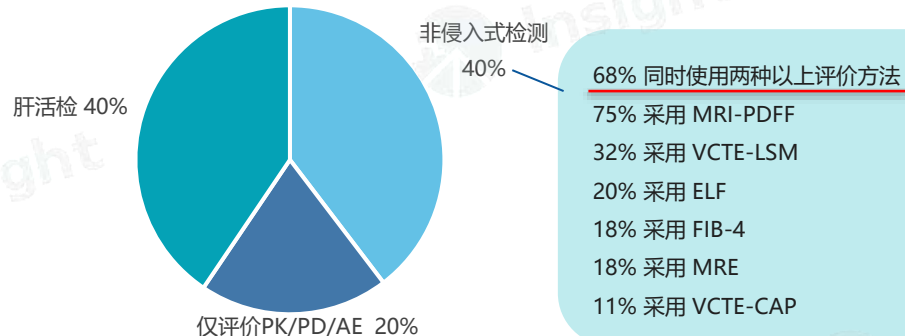
常见非侵入式 MASH 检测方法

类型	简称	检测内容	特点
血清	BARD	BMI、血糖、AST/ALT	可用于检测纤维化，检测 MASH 的 AUC 在 0.8 左右
	APRI	AST/血小板比率指数	
	FIB-4	年龄、血小板、AST、ALT	
	NFS	年龄、BMI、血糖、血小板、白蛋白、AST/ALT	
	ELF	PIIINP、透明质酸和 TIMP1	
显像	MRE	磁共振弹性成像	可用于定性检测肝脂肪变性，不可量化 可用于定量检测肝脂肪变性，检测 MASH 的 AUC 达到 0.9
	VCTE-LSM	瞬时弹性成像（超声）	
	VCTE-CAP	瞬时弹性成像+受控衰减参数	
	MRI-PDFF	磁共振质子密度脂肪分数成像	
血清+显像	FAST	VCTE + AST	近期研究表明检测 MASH 的 AUC 可达到 0.85~0.9，待进一步验证
	MAST	MRI-PDFF + MRE + AST	
	MEFIB	MRE + FIB-4	

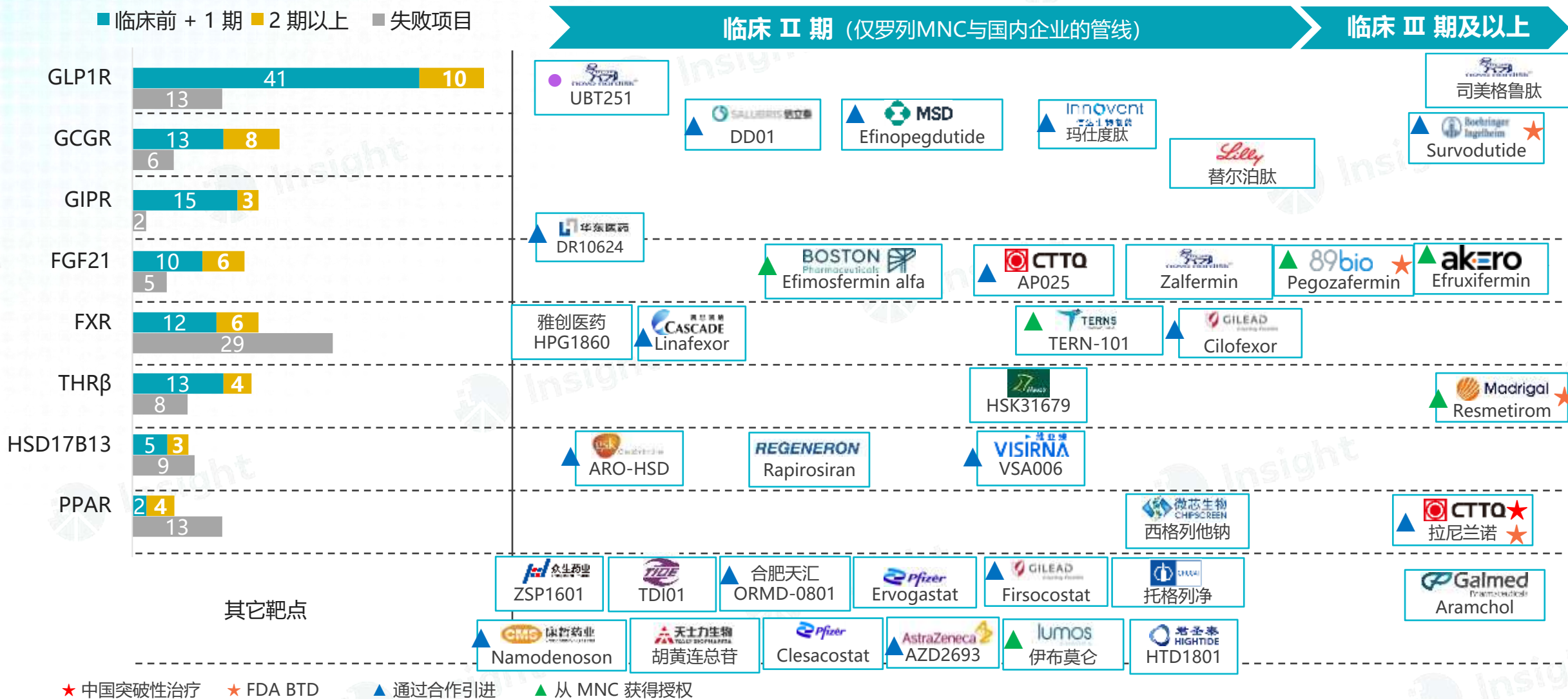
近 5 年 MASH 临床入组标准



近 5 年 MASH 临床终点评价标准



MASH 机制仍不完全明确，有多个靶点在推进，授权合作比例很高



基于已读出的临床结果，THRβ、GLP1R、FGF21 三个靶点相对更成熟

产品	企业	靶点	临床	筛选人数	入组人数	纤维化基线	MASH 缓解，肝纤维化无恶化	肝纤维化改善，MASH 无恶化
Resmetirom	Madrigal	THRβ	MAESTRO-NASH	2000+	888	Fibrosis F2~3	36 vs 13	28 vs 15
司美格鲁肽	诺和诺德	GLP1R	ESSENCE		1197	Fibrosis F2~3	62.9 vs 34.1	37.0 vs 22.5
Efruxifermin	Akerio	FGF21	HARMONY	747	128	Fibrosis F2~3	57 vs 24	★75 vs 24
			SYMMETRY	652	182	Fibrosis F4		39 vs 15
survodutide	BI	GLP1R/GCGR	NCT04771273		295	Fibrosis F1~3	65.9 vs 18.2	50 vs 21.2
						Fibrosis F2~3		65.4 vs 25.9
Pegozafermin	89bio	FGF21	ENLIVEN		222	Fibrosis F2~3	26 vs 2	27 vs 7
地尼法司▲	Sagimet/歌礼	FASN	FASCINATE-2	1087	168	Fibrosis F2~3	52 vs 20	41 vs 18
拉尼兰诺	Inventiva/正大天晴	PPAR	NATIVE	868	247	Fibrosis F1~3	49 vs 22	48 vs 29
VK2809	Viking	THRβ	VOYAGE		178	Fibrosis F1~3	★75 vs 29	57 vs 34
替尔泊肽	礼来	GLP1R/GIPR	SYNERGY-NASH	1583	190	Fibrosis F2~3	★73.3 vs 13.2	51.0 vs 29.7
Efimosfermin alfa	Boston Pharma	FGF21	BOS-580-201		84	Fibrosis F2~3	67.7 vs 29.4	45.2 vs 20.6

*优先选择 mITT 数值，对照组均为安慰剂 ▲ 关键临床招募前撤回

筛查失败率：82%

肝活检评估可靠性欠佳

- Azemiglitazone 2 期失败后，3 位病理学家重新独立评估
- 各项参数kappa系数为 0.4~0.6
 - 原先有 1 位专家判定符合纳入标准的读片结果，有 46.3% 被 3 位中的 1 位判定不符合标准

MASH 适应症的发展趋势

开发更便利地诊断方式

减少患者负担，增加方法的可靠性与可行性，简化临床流程与评价方法。

个体化治疗

基于患者 MASH、纤维化、并发症的不同情况进行针对性治疗。

机制研究

挖掘致病因子与信号通路，为精准治疗提供依据。

风险均摊

风险与机遇并存，面对高难度项目谋求均摊风险的意愿更大。

扫码获取全文



截图保存后微信识别二维码，进入 PDF 下载

分析细分人群竞争格局，寻找未满足的临床需求

使用模块：疾病竞争格局

「疾病竞争格局」为一个疾病精细化的定义出各类潜在的立项人群，并通过 4 大核心功能，将不同细分人群中的竞争格局、临床疗效、指南药物、流行病学清晰直观地展示出来，帮助用户洞悉当前疾病下的未满足需求以及细分赛道的竞争格局和潜力项目。

